



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 19-10-2024 16:20:49

Página 1 de 6

Información Paciente

Nombre : Waldo Antonio Avendano Diaz	Rut : 16.247.316-6	N° Archivo : 1522848	N° Epicrisis
Edad : 39a 2m 13d	Fecha Nacto : 06/08/1985	Sexo : Masculino	415575
Dirección : Santa Elena 115	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 6904 3760	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)	Fecha Ingreso : 21/09/2024	01:47	Días Estadía : 28
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso : 19/10/2024	16:10	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

16/10/2024 11:22:40
J.Madariaga
19° día UCI
DIAGNÓSTICOS
Tumor mediastínico en estudio
-Sospecha de Linfoma
>>Sx de Lisis tumoral grave en mejoría
IRA
-Sx V. cava superior
-Remodelado pulmonar por MTT
>>1er ciclo de Prono 02/10 ¿ 03/10
>>2° ciclo de Prono 07/10 ¿ 14/10
AKI KDIGO III multifactorial
Neutropenia Febril sin foco
-14° día Imipenem
-Vancomicina/Ecalta 09-14/10
LPP Pre-deltaidea derecha.
Antecedentes

Paciente conocido. En estudio por tumor mediastínico anterior, tratado empíricamente con Ciclofosfamida + Dexametasona. Cursa con lisis tumoral severa con falla renal (requiriendo TRR) y hepática asociada. En últimos días con mejoría franca.

Hoy en mejores condiciones, hemodinamia aun algo inestable aunque con dosis bajas de NAD. Afebril. FiO2 estable. Sin diuresis ni deposiciones. Nutrición enteral por SNG lejos de meta, pero hoy con menor residuo.

Diuresis: (-) Depo: -6
VMI VC/AC Vt: 450 Ppico: 26 Pplateau: 24 PEEP: 14 DP: 10 FiO2 35%

HOY AngioTAC de Tórax + TAC AP con intención de seguimiento de tamaño de tumor mediastínico, búsqueda de foco infeccioso oculto (aunque ya afebril y PPII francamente bajos).

Fecha Epicrisis : 19/10/2024 16:20

Página 1 de 6

Fecha Última Actualización: 19-10-2024 16:20:49

Página 2 de 6

General: hidratado, bien perfundido, SAS 1, llene capilar <3 segundos.

Cuello: yugulares planas

Cardíaco: RR2TSS, no ausculto soplos

Pulmonar: MP (+) disminuido hacia las bases y sobre todo a derecha.

Abdomen: RHA disminuido, blando, no palpo masas.

Extremidades: pulsos simétricos, edema +/-, sin signos sugerentes de TVP

LPP en región pre-deltaidea grado 1.

HDN: bien perfundido, NAD a dosis bajas persistente para PAM objetivo, Monitorización con LA. Taquicardia conocida interpretada como secundaria a lisis + efecto de masa de tumor.

Respiratorio: en VMI VC con BNM, supinado 14/10 con mantención de estabilidad. Considerando BNM prolongado y desconocimiento de anatomía actual (post-QMT) se decide mantener hasta TAC (hoy), una vez realizado y si existe mejoría se podría iniciar suspensión de bloqueo.

Infeccioso: Sin infección consignada ni microbiología aislada en últimos estudios. Bajo cobertura prolongada con Imipenem (+ Vancomicina y Anidulafungina ya suspendidos). Se ha mantenido en general tratamiento antibiótico por Neutropenia Febril. Considerando recuperación de RAN, afebril hace más de 1 semana, mejoría clínica y ausencia de sustento microbiológico se completarán 14 días de tratamiento y suspender.

Una vez con imagen IC a infectología para definir necesidad de terapia supresora.

Hepático: elevación significativa de pruebas hepáticas con prolongación de INR hace 1 semana. Etiología poco clara, aunque podría estar en contexto de shock vs compromiso infiltrativo tumoral. Actualmente lentamente en mejoría. Seguimiento.

Renal: deterioro de función renal etiología multifactorial. Requiriendo inicialmente diálisis intermitente y luego TRR continua por 120 horas. Considerando mejoría se decide suspender terapia y seguimiento de parámetros nitrogenados y electrolitos. Hoy SLED para manejo volumétrico y de uremia leve.

Oncológico/Hematológico: Ingreso para estudio de tumor mediastínico. Evaluado por equipo ante gravedad se inicia citorreducción con ciclofosfamida administrada el 02/10 y dexametasona 40 mg/día completando 5 días. CMF de MTT hepática indeterminada. Viernes 11/10 se realizó mielograma y envío muestra a hospital Salvador para CMF. En seguimiento por equipo. Conversado con Dr. Arrosamena de radiología intervencional se decide re-tomar biopsia el jueves 17/10 idealmente.

Profilaxis: IBP + HNF (suspender hoy PM)

Manejo activo.

17/10/2024 10:09:26

J.Madariaga

20° día UCI

DIAGNÓSTICOS

Tumor mediastínico en estudio

-Sospecha de Linfoma

>>Sx de Lisis tumoral grave en mejoría

IRA

-Sx V. cava superior

-Remodelado pulmonar por MTT

-Atelectasia completa pulmón izquierdo

>>1er ciclo de Prono 02/10 ¿ 03/10

>>2° ciclo de Prono 07/10 ¿ 14/10

AKI KDIGO III multifactorial

LPP Pre-deltaidea derecha.

Antecedentes

Fecha Epicrisis : 19/10/2024 16:20

Página 2 de 6

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:35

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 19-10-2024 16:20:49

Página 3 de 6

Paciente conocido. En estudio por tumor mediastínico anterior, tratado empíricamente con Ciclofosfamida + Dexametasona. Cursa con lisis tumoral severa con falla renal (requiriendo TRR) y hepática asociada. En últimos días con mejoría franca.

Hoy en mejores condiciones, hemodinamia aun algo inestable aunque con dosis bajas de NAD. Afebril. FiO2 estable. Logra deposiciones ayer. Nutrición enteral por SNG lejos de meta aun.

De sus exámenes franca mejoría en todos los parámetros. Destaca ayer en TAC de control estabilidad de masa (es decir nula respuesta macroscópica a terapia) y de hecho progresión con metastasis nuevas en retroperitoneo y suprarrenales.

Diuresis: (-) Depo: +

VMI VC/AC Vt: 430 Ppico: 23 Pplateau: 19 PEEP: 12 DP: 7 FiO2 30%

General: hidratado, bien perfundido, SAS 1, llene capilar <3 segundos.

Cuello: yugulares planas

Cardiaco: RR2TSS, no ausculto soplos

Pulmonar: MP (+) disminuido hacia las bases y sobre todo a derecha.

Abdomen: RHA disminuido, blando, no palpo masas.

Extremidades: pulsos simétricos, edema +/-, sin signos sugerentes de TVP

LPP en region pre-deltaidea grado 1.

HDN: bien perfundido, NAD a dosis bajas persistente para PAM objetivo, Monitorización con LA. Taquicardia conocida interpretada como secundaria a lisis + efecto de masa de tumor.

Respiratorio: en VMI VC con BNM, supinado 14/10 con mantención de estabilidad. TAC muestra persistencia de atelectasia completa de pulmón derecho. En ese sentido se evaluará suspensión de BNM.

Infeccioso: Sin infección consignada ni microbiología aislada en últimos estudios. Bajo cobertura prolongada con Imipenem (+ Vancomicina y Anidulafungina ya suspendidos). Se ha mantenido en general tratamiento antibiótico por Neutropenia Febril. Considerando recuperación de RAN, afebril hace más de 1 semana, mejoría clínica y ausencia de sustento microbiológico se completan 14 días de tratamiento. Considerando imagen sin cambios significativos pero así mismo sin evidencia radiológica de neumonía post-obstructiva se decide mantener en ventana ATB.

Hepático: elevación significativa de pruebas hepáticas con prolongación de INR hace 1 semana. Etiología poco clara, aunque podría estar en contexto de shock vs compromiso infiltrativo tumoral. Actualmente lentamente en mejoría. Seguimiento.

Renal: deterioro de función renal etiología multifactorial. Requiriendo inicialmente diálisis intermitente y luego TRR continua por 120 horas. Considerando mejoría se decide suspender terapia y seguimiento de parámetros nitrogenados y electrolitos. Último SLED ayer. Seguimiento.

Oncológico/Hematológico: Ingreso para estudio de tumor mediastínico. Evaluado por equipo ante gravedad se inicia citorreducción con ciclofosfamida administrada el 02/10 y dexametasona 40 mg/día completando 5 días. CMF de MTT hepática indeterminada. Viernes 11/10 se realizó mielograma y envío muestra a hospital Salvador para CMF. En seguimiento por equipo. Conversado con Dr. Arrosamena de radiología intervencional se decide re-tomar biopsia HOY, sin incidentes.

Profilaxis: IBP por paciente grave en UPC y tromboprofilaxis con HNF por clearance menor a 30 ml/min.

Manejo activo.

17/10/2024 11:39:33

J.Arrosamena

Se realiza biopsia de lesion focal hepatica en el lobulo hepatico izquierdo.

Procedimiento bien tolerado, sin complicaciones inmediatas.

No se dispone de imágenes en el sistema debido a que procedimiento es realizado con ecografo de UCI.

Fecha Epicrisis : 19/10/2024 16:20

Página 3 de 6

Fecha Última Actualización: 19-10-2024 16:20:49

Página 4 de 6

-
-
- Monitorización
- Regimen 0. Luego realimentar segun indicacion de equipo tratante.
- Reposo absoluto.
- Frio local. Vigilar sitio de punción.

18/10/2024 11:48:27

J.Madariaga

20° día UCI

DIAGNÓSTICOS

Tumor mediastínico en estudio

-Sospecha de Linfoma

>>Sx de Lisis tumoral grave en mejoría

IRA

-Sx V. cava superior

-Remodelado pulmonar por MTT

-Atelectasia completa pulmón izquierdo

>>1er ciclo de Prono 02/10 ¿ 03/10

>>2° ciclo de Prono 07/10 ¿ 14/10

AKI KDIGO III multifactorial

LPP Pre-deltaoidea derecha.

Antecedentes

Paciente conocido. En estudio por tumor mediastínico anterior, tratado empíricamente con Ciclofosfamida + Dexametasona. Cursa con lisis tumoral severa con falla renal (requiriendo TRR) y hepática asociada. En últimos días con mejoría franca.

Hoy en similares condiciones, hemodinamia aun algo inestable con dosis bajas de NAD. Afebril. FiO2 estable. Logra deposiciones. Nutrición enteral por SNG en plan de aumentar aporte para llegar a meta.

De los exámenes de hoy destaca mejoría en general de PPHH, LDH y PPII. Estabilidad de INR. Lactato levemente elevado probablemente en contexto de efeto Warburg.

Diuresis: (-) Depo: +

VMI VC/AC Vt: 430 Ppico: 23 Pplateau: 18 PEEP: 10 DP: 7 FiO2 30%

General: hidratado, bien perfundido, SAS 1, llene capilar <3 segundos.

Cuello: yugulares planas

Cardiaco: RR2TSS, no ausculto soplos

Pulmonar: MP (+) disminuido hacia las bases y sobre todo a derecha.

Abdomen: RHA disminuido, blando, no palpo masas.

Extremidades: pulsos simétricos, edema +/-, sin signos sugerentes de TVP

LPP en region pre-deltaoidea grado 1.

LPP sara Grado 1

HDN: bien perfundido, NAD a dosis bajas persistente para PAM objetivo, Monitorización con LA. Taquicardia conocida interpretada como secundaria a lisis + efecto de masa de tumor. Destaca leve elevación nde lactato que podría estar en contexto de efecto Warburg por neoplasia activa.

Respiratorio: en VMI VC con BNM, supinado 14/10 con mantención de estabilidad. TAC muestra persistencia de atelectasia completa de pulmón derecho. Desde hoy sin bloqueo neuromuscular.

Infeccioso: Sin infección consignada ni microbiología aislada en últimos estudios. Bajo cobertura prolongada con Imipenem (+ Vancomicina y Anidulafungina ya suspendidos). Se ha mantenido en general tratamiento antibiótico por Neutropenia Febril. Considerando recuperación de RAN, afebril hace más de 1 semana, mejoría clínica y ausencia de sustento microbiológico se completan 14 días de tratamiento. Considerando imagen sin cambios significativos pero así mismo sin evidencia radiológica de neumonía post-obstructiva se decide mantener en ventana ATB.

Hoy peak febril sin compromiso hemodinámico. considerando RAN recuperado y estabilidad clínica se decide tomar cultivos sin

Fecha Epicrisis : 19/10/2024 16:20

Página 4 de 6

Fecha Última Actualización: 19-10-2024 16:20:49

Página 5 de 6

inicio de terapia empírica. Observación y partir tratamiento según microbiología.

Hepático: elevación significativa de pruebas hepáticas con prolongación de INR hace 1 semana. Etiología poco clara, aunque podría estar en contexto de shock vs compromiso infiltrativo tumoral. Actualmente lentamente en mejoría. Seguimiento.

Renal: deterioro de función renal etiología multifactorial. Requiriendo inicialmente diálisis intermitente y luego TRR continua por 120 horas. Considerando mejoría se decide suspender terapia y seguimiento de parámetros nitrogenados y electrolitos. Hoy nueva SLED.

Oncológico/Hematológico: Ingreso para estudio de tumor mediastínico. Evaluado por equipo ante gravedad se inicia citorreducción con ciclofosfamida administrada el 02/10 y dexametasona 40 mg/día completando 5 días. CMF de MTT hepática indeterminada. Viernes 11/10 se realizó mielograma sin visibilizarse células neoplásicas en la muestra (según conversado con Dr. Berkovits) y envío muestra a hospital Salvador para CMF. En seguimiento por equipo. Conversado con Dr. Arrosamena de radiología intervencional se decide re-tomar biopsia ayer con urgencia.

Profilaxis: IBP por paciente grave en UPC y trombopprofilaxis con HNF por clearance menor a 30 ml/min.

Manejo activo.

19/10/2024 10:11:08

H.Clausdorff

Se recibe a paciente en entrega de turno hipotenso a pesar de NAD a 0,5ug/kg/min

Sin respuesta a HCO₃, Doble DVA

POCUS sin actividad eléctrica organizada, Ritmo baja de 300? a 45x' QRS Ancho

Tomando en contexto antecedentes, exámenes de control (Acidótico, hiperlactatemia, coagulopata y falla renal) y pronóstico de enfermedad, se decide adecuación de esfuerzo terapéutico y titular terapias para manejo paliativo

Paciente desarrolla asistolía a las 9:50, declarándose fallecido

Doy aviso a familiares y entrego certificado de defunción

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Renal Aguda - Sd Lisis Tumoral - Falla Multiorgánica

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallece 10:10 Familiares al tanto

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 19/10/2024 16:20

Página 5 de 6

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:35

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 19-10-2024 16:20:49

Página 6 de 6

INTERNO

Becado/Residente

Hans Clausdorff Fiedler

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 19/10/2024 16:20

Página 6 de 6

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:35

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar